PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SOLICITAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA / TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA

Limpar

Imprimir

EU _____,

NOME SOCIAL _____, COM DATA DE NASCIMENTO _____/_____/_____,

PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° _____, INSCRITA SOB O CPF _____, RESIDENTE E DOMICILIADA À _____,

CIDADE DE _____, ESTADO DE _____,

ATUALMENTE COM _____ ANOS DE IDADE E _____ FILHOS(AS) VIVOS(AS), CIENTE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE, MANIFESTO O DESEJO DE SER SUBMETIDA À LAQUEADURA TUBÁRIA, POR MINHA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE.

ESTOU CIENTE QUE, ENTRE A DATA DA MANIFESTAÇÃO DA MINHA VONTADE À EQUIPE DE SAÚDE (IDENTIFICADA ABAIXO NESTE DOCUMENTO) E O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DEVERÃO SE PASSAR AO MENOS 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME A LEI NO 9.263/1996, ALTERADA PELA LEI Nº 14.443, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022 E QUE, DE ACORDO COM A MESMA LEI, DESDE QUE OBSERVADO ESSE PRAZO MÍNIMO, É PERMITIDA A LAQUEADURA DURANTE O PERÍODO DE PARTO.

ANTES DA OPERAÇÃO, FOI-ME INFORMADO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE QUE:

- O PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA CONSISTE NA INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DAS TUBAS UTERINAS, COM O OBJETIVO DE IMPEDIR GRAVIDEZ.

- PARA REALIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE CIRURGIA E A QUE SERÁ REALIZADA DEPENDERÁ DE CADA SERVIÇO HOSPITALAR:
  - LAPAROSCÓPICA: CIRURGIA REALIZADA POR MEIO DE TRÊS OU QUATRO PEQUENOS CORTES REALIZADOS NO ABDOME;
  - MICRO LAPAROTOMIA: SEMELHANTE A UMA CICATRIZ DE CESARIANA, PORÉM MENOR;
  - VAGINAL: CIRURGIA REALIZADA PELA VAGINA;
  - PÓS-CESARIANA: LAQUEADURA TUBÁRIA NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CESARIANA;
  - PERIUMBILICAL: LAQUEADURA REALIZADA LOGO APÓS O PARTO VAGINAL, ATRAVÉS DE UM CORTE AO REDOR DO UMBIGO.

- QUALQUER CIRURGIA QUE VENHA A SER REALIZADA NECESSITA DE ALGUMA ANESTESIA. O TIPO DE CIRURGIA E DE ANESTESIA SERÁ AVALIADO E ESCOLHIDO PELO(A) MÉDICO(A) ASSISTENTE E PELA EQUIPE DE ANESTESIA DO HOSPITAL.

- EXISTEM OUTROS MÉTODOS DE CONTRACEPÇÃO REVERSÍVEIS E EFICAZES, COMO OS MÉTODOS DE BARREIRA, DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E MÉTODOS HORMONAIS, BEM COMO MÉTODOS NATURAIS E MÉTODOS DE CONTRACEPÇÃO REVERSÍVEIS PARA MINHA PARCERIA, DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EXISTE AINDA A VASECTOMIA, UM MÉTODO DEFINITIVO DE CONTRACEPÇÃO PARA MINHA PARCERIA, CASO APLICÁVEL, MAIS SIMPLES E QUE NÃO REQUER INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

- EMBORA O MÉTODO DE LAQUEADURA TUBÁRIA ESTEJA ENTRE OS MAIS EFETIVOS MÉTODOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, SUA EFETIVIDADE NÃO É DE 100%. EXISTE UMA PORCENTAGEM DE FALHA EM TORNO DE 0,41%, QUE INDEPENDE DA PACIENTE OU DO(A) MÉDICO(A).

- DEPENDENDO DA SITUAÇÃO, ALGUMAS PESSOAS QUE FAZEM A LAQUEADURA TUBÁRIA SE ARREPENDEM DE TER REALIZADO. A LAQUEADURA TUBÁRIA É UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONSIDERADO DEFINITIVO E AS TENTATIVAS DE REVERSÃO NÃO TÊM SUCESSO GARANTIDO, DEVENDO, PORTANTO, SER ENTENDIDA COMO IRREVERSÍVEL.

- A LAQUEADURA TUBÁRIA NÃO PREVINE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, SENDO IMPORTANTE O USO DE PRESERVATIVOS, DISPONIBILIZADOS PELO SUS, MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

- ENTRE AS POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA TUBÁRIA ESTÃO:
  - INTRA-OPERATÓRIAS: HEMORRAGIA, LESÕES DE ÓRGÃOS INTERNOS, QUEIMADURAS POR BISTURI ELÉTRICO, COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À ANESTESIA;
  - PÓS-OPERATÓRIAS LEVES E MAIS FREQUENTES: SEROMAS, HEMORRAGIA, HEMATOMA, INFECÇÃO URINÁRIA, ANEMIA;
  - PÓS-OPERATÓRIAS GRAVES E EXCEPCIONAIS: HEMORRAGIA, ABERTURA DA CICATRIZ CIRÚRGICA, SAÍDA DOS ÓRGÃOS ABDOMINAIS PELA ABERTURA DA CICATRIZ CIRÚRGICA, TROMBOSE, PARADA RESPIRATÓRIA, INFECÇÃO PÉLVICA E/OU ABDOMINAL.

- COMO EM TODA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EXISTE UM RISCO EXCEPCIONAL DE MORTALIDADE, INERENTE AO ATO CIRÚRGICO E A SITUAÇÃO VITAL DE CADA PACIENTE.

- SE NO MOMENTO DO ATO CIRÚRGICO SURGIR ALGUM IMPREVISTO OU NECESSIDADE TÉCNICA, A EQUIPE MÉDICA PODERÁ VARIAR A TÉCNICA CIRÚRGICA PROGRAMADA OU OPTAR PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.

- O PROCEDIMENTO PLANEJADO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DURANTE O PERÍODO DE PARTO (APÓS PASSADO O PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS ENTRE A MANIFESTAÇÃO DA MINHA VONTADE E O PARTO) PODERÁ SOFRER MUDANÇAS DE TÉCNICA OU POSTERGADO, DEVIDO A CONDIÇÕES MÉDICAS, TÉCNICAS OU DE ESTRUTURA ASSISTENCIAL DA MATERNIDADE. POSSÍVEIS CONDIÇÕES QUE PODERÃO CONTRAINDICAR A LAQUEADURA TUBÁRIA NO MOMENTO DO PARTO: HEMORRAGIA; INFECÇÃO; COMPLICAÇÕES MATERNAS QUE NECESSITEM DE INTERVENÇÕES MAIS URGENTES, COMO ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, ENTRE OUTRAS.

- POR SE TRATAR A MEDICINA DE CIÊNCIA COM MÚLTIPLAS VARIÁVEIS, DO MEU PRÓPRIO CORPO, DE DIFICULDADES OU INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES QUE PODEM SE APRESENTAR NO MOMENTO, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL REALIZAR A LAQUEADURA, A FUNDAMENTAÇÃO SERÁ REGISTRADA EM PRONTUÁRIO E A EQUIPE MÉDICA ORIENTARÁ OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A GRAVIDEZ E QUE SEJA APLICÁVEL NO MEU CASO.

- É POSSÍVEL COLOCAR UM DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) NA MESMA INTERNAÇÃO DO PARTO (NORMAL OU CESARIANA) OU DA PERDA GESTACIONAL.

- NO CONTEXTO DE PARTO, MEU DESEJO DE LAQUEADURA NÃO SIGNIFICA JAMAIS A INDICAÇÃO DE CESARIANA, VISTO AS OUTRAS TÉCNICAS DESCRITAS PARA LAQUEADURA PÓS-PARTO E QUE PODEM SER APLICADAS NO CASO DE PARTO VIA VAGINAL, E SER PROIBIDO POR LEI REALIZAR CESARIANA PARA FIM EXCLUSIVO DE ESTERILIZAÇÃO. O PARTO SERÁ REALIZADO PELA VIA OBSTÉTRICA INDICADA PARA O MEU CASO.

TENHO CIÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 11 DA LEI 9263/1996, QUE TODA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA SERÁ OBJETO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

ENTENDI AS EXPLICAÇÕES QUE ME FORAM PRESTADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE, EM LINGUAGEM CLARA E SIMPLES, ESCLARECENDO-ME TODAS AS DÚVIDAS QUE ME OCORRERAM. TAMBÉM ENTENDI QUE, A QUALQUER MOMENTO, ANTES QUE O PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA SE REALIZE E SEM NECESSIDADE DE DAR NENHUMA EXPLICAÇÃO, PODEREI REVOGAR O CONSENTIMENTO QUE AGORA PRESTO, SEM NENHUM PREJUÍZO PARA O MEU ATENDIMENTO.

DECLARO QUE ESTOU SATISFEITA COM AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS E QUE EU COMPREENDI O ALCANCE E OS RISCOS DO TRATAMENTO. CONSINTO, PORTANTO AO(A) MÉDICO(A) A REALIZAR O(S) PROCEDIMENTO(S) E PERMITO QUE UTILIZE SEU JULGAMENTO TÉCNICO PARA QUE SEJAM ALCANÇADOS OS MELHORES RESULTADOS POSSÍVEIS ATRAVÉS DOS RECURSOS CONHECIDOS NA ATUALIDADE PELA MEDICINA E DISPONÍVEIS NO LOCAL ONDE SE REALIZA O(S) TRATAMENTO(S).

CONFIRMO QUE RECEBI EXPLICAÇÕES, LI, COMPREENDI E CONCORDO COM OS ITENS ACIMA REFERIDOS E, APESAR DE TER ENTENDIDO AS EXPLICAÇÕES QUE ME FORAM PRESTADAS, DE TEREM SIDO ESCLARECIDAS TODAS AS DÚVIDAS E ESTANDO PLENAMENTE SATISFEITA COM AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, RESERVO-ME O DIREITO DE REVOGAR ESTE CONSENTIMENTO ANTES QUE O PROCEDIMENTO, OBJETO DESTE DOCUMENTO, SE REALIZE.

DATA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE	ASSINATURA DA USUÁRIA	
DATA	CARIMBO E ASSINATURA DO(A) MÉDICO(A) DA UNIDADE	BM